Клинические рекомендации

Туберкулёз у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A15** — Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически **A16** — Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически **A17** — Туберкулез нервной системы **A18** — Туберкулез других органов **A19** — Милиарный туберкулез
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 16.01.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Российское Общество Фтизиатров; Национальная ассоциация некоммерческих организаций фтизиатров «Ассоциация фтизиатров»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/16_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Классификация 2

3. Диагностика 2

3.1 Жалобы и анамнез 2

3.2 Лабораторные исследования 3

3.3 Туберкулёз периферических лимфатических узлов 3

3.4 Консультации специалистов 3

4. Лечение 3

4.1 Химиотерапия лекарственно-чувствительного туберкулёза 3

4.2 Ототоксичность противотуберкулёзных препаратов 3

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 3

5.1 Показания к госпитализации 3

6. Источник и актуальность 4

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 4

1. Основные положения

- Туберкулёз — инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями группы Mycobacterium tuberculosis complex. Среди внелегочных форм — туберкулёз уха, туберкулёзная периферическая лимфаденопатия; среди форм органов дыхания — туберкулёз гортани.
- Внелегочный туберкулёз заподозрить следует при неэффективности стандартного лечения, частых рецидивах «неспецифического» заболевания и свищах любой локализации. Для исключения внелегочного туберкулёза назначается осмотр оториноларинголога.
- Перед назначением канамицина, амикацина и капреомицина выполняется тональная аудиометрия, во время лечения — **ежемесячно**: аминогликозиды ототоксичны и вестибулотоксичны.
- Госпитализация в круглосуточный стационар показана при бактериовыделении, осложнениях, среднетяжёлом и тяжёлом течении, распространённых и внелегочных формах.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Туберкулёз — инфекционное заболевание, которое вызывается патогенными микобактериями, относящимися к группе Mycobacterium tuberculosis complex.

2.2 Классификация

Внелегочные формы

1. туберкулёз костей и суставов;
2. туберкулёз мочеполовых органов;
3. туберкулёзная периферическая лимфаденопатия;
4. туберкулёз глаза;
5. туберкулёз уха;
6. туберкулёз кожи и подкожной клетчатки и другие.

Стадии туберкулёза периферических лимфатических узлов

1. инфильтративная;
2. казеозная;
3. абсцедирующая.

3. Диагностика

3.1 Жалобы и анамнез

Когда заподозрить внелегочный туберкулёз

1. неэффективность стандартного лечения;
2. частые рецидивы «неспецифического» заболевания, под маской которого протекает внелегочный туберкулёз;
3. появление свищей любой локализации.

Патогномоничных симптомов у внелегочного туберкулёза нет; важны длительность заболевания, проведённое лечение, контакт с больными туберкулёзом.

3.2 Лабораторные исследования

Для этиологической диагностики выполняется молекулярно-биологическое исследование мокроты или другого диагностического материала на ДНК Mycobacterium tuberculosis complex; при выявлении ДНК повторно исследование не выполняется.

3.3 Туберкулёз периферических лимфатических узлов

При периферической лимфаденопатии и подозрении на туберкулёз выполняется УЗИ лимфатических узлов с последующей биопсией и гистологической верификацией; материал исследуют также молекулярно-биологическими и культуральными методами.

Пункционная биопсия малоинформативна при сохранённой ультразвуковой структуре узла. Получение гноя при пункции — показание к вскрытию и дренированию аденофлегмоны; заживление раны может длиться до 3–4 месяцев.

3.4 Консультации специалистов

Для исключения внелегочного туберкулёза назначается осмотр специалистов, в том числе оториноларинголога, офтальмолога, уролога, гинеколога, невролога, хирурга.

---

4. Лечение

4.1 Химиотерапия лекарственно-чувствительного туберкулёза

В интенсивную фазу назначается комбинация из 4 препаратов первого ряда: изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол; в фазу продолжения — как минимум 3 препарата первого ряда.

4.2 Ототоксичность противотуберкулёзных препаратов

Среди наиболее частых побочных реакций химиотерапии — ототоксические реакции.

Перед назначением канамицина, амикацина и капреомицина выполняется тональная аудиометрия; при лечении — **ежемесячно**.

Наблюдение при лечении канамицином и амикацином

1. **ототоксичность** — оценка жалоб на шум в ушах, снижение слуха; тональная аудиометрия ежемесячно
2. **вестибулотоксичность** — оценка жалоб на головокружение, неустойчивость, тошноту, рвоту; выявление нистагма

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации в круглосуточный стационар

1. бактериовыделение, определяемое любым микробиологическим методом;
2. осложнения туберкулёза;
3. среднетяжёлое и тяжёлое течение, распространённые диссеминированные формы, внелегочная локализация;
4. среднетяжёлые и тяжёлые неустранимые побочные реакции на противотуберкулёзные препараты при амбулаторном лечении;
5. сопутствующие заболевания среднетяжёлого или тяжёлого течения.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Туберкулёз у взрослых»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 16.01.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2029 года
Код в рубрикаторе	16_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество фтизиатров; Ассоциация фтизиатров
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.